5.治疗 病例题必看血压,不同疾病休克处理方式不同 e.g 高危肺栓塞(休克):溶栓
张力性气胸(休克):立即穿刺排气

（1）90%通过保守治疗控制出血

电解质含量与血浆含量相仿

①已休克（收缩压＜90mmHg）首选补充血容量（补平衡盐溶液）生理盐水中的Cl-高于血浆,容易导致高氯血症

②未休克：闭塞性增殖性动脉内膜炎作用①止血(出血量不大)②血供↓不利于愈合

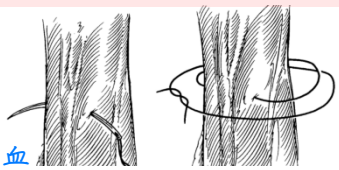
表 4-5-3　PU 出血的内镜特点与治疗策略　PPI抑酸→抑制胃蛋白酶→减少血凝块消化
→PH↑→利于血小板聚集

四种情况 内镜特点	再出血率/%	治疗策略
活动性动脉出血	90	PPI+内镜下治疗,必要时血管介入治疗或手术
裸露血管	50	PPI+内镜下治疗
血凝块	25～30	PPI,必要时内镜下治疗
溃疡不伴血迹	＜5	PPI

内镜不仅可以起到一个诊断的作用,还可以进行很多的操作
e.g 胃镜下喷洒蛋白凝胶、在出血部位打肾上腺素、进行热凝固术

十版新增

注意：当内镜未能发现病灶，估计有消化道动脉性出血时，可行选择性血管造影，若见造影剂外溢则是消化道出血最可靠的征象，可立即予以经导管栓塞止血　动脉性出血量大且持续



（2）外科治疗　通用

①指征：内科治疗无效（如出血快短期休克）、高龄伴动脉硬化、曾有类似大出血　血管壁脆,出血难以自行停止
短期内很可能会再出血

②方法：急症剖腹探查行贯穿缝扎术

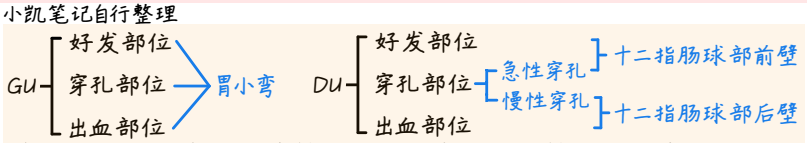
（二）穿孔

1.多数穿孔与服用 NSAIDs 有关 胃黏膜局部PG↓→保护因素↓屏障功能↓

2.好发部位：GU-胃小弯，DU 急性穿孔-球部前壁、慢性穿孔-球部后壁（以急性穿孔常见）

注意：GU 好发部位、出血好发部位、穿孔好发部位在胃小弯；DU 好发部位、急性穿孔好发部位在球部前壁，而 DU 出血和慢性穿孔好发部位在球部后壁（袜子-前面穿孔、后面出血）　薄、无支撑

小凯笔记自行整理



3.慢性穿孔（穿透性溃疡）的临床表现

①背部痛

②有时可穿透至胰腺致淀粉酶增高；有时可穿破入空腔器官形成瘘管（如 DU 穿破胆总管形成胆瘘）。CT 对于穿透性溃疡的判定很有价值　两端相通"吸管"

4.急性穿孔的临床表现　VS急性阑尾炎经典的转移性右下腹痛
但其右下腹(麦氏点)最痛

消化液对腹膜的刺激最强

①突发上腹刀割样剧痛，迅速波及全腹、以穿孔处最重（关注原发疾病部位）（pia 突然破了、或突然堵了-突发）

②急性腹膜炎：腹膜刺激征（压痛、反跳痛、肌紧张呈 ttsx 板状腹）继发性腹膜炎

③肠鸣音↓ 腹膜炎　从外面抑制肠子

④肝浊音界缩小消失（最有价值体征）　气体覆盖在肝周围影响查体

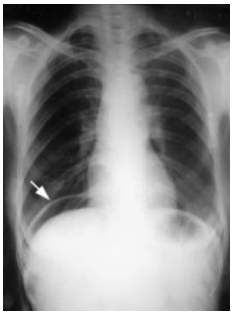
⑤可有转移性右下腹痛

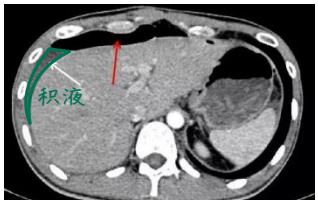
⑥可有移动性浊音（腹水＞1000ml）

⑦若上腹触及包块→胃肠内容物被包裹→穿刺置管引流

⑧若发热、右上腹痛、呃逆→膈下脓肿　肝脏周围是负压,会吸引气体、液体







5.检查

①首选 X 线：膈下新月形游离气体　气体聚在肝脏的周围

②腹腔穿刺：抽出黄色浑浊含胆汁食物残渣　次选

VS 外科:腹部损伤有腹穿选腹穿